

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術 Care, Removing and Urine-Sampling of Foley Catheter				
編號	A31000-Q05-W-A27	制定者	R12 吳育娟	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.8 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作存留導尿管之護理與拔除技術及留置導尿管之抽取尿液檢體技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.清潔外陰部，預防膀胱、會陰及肛門等處之感染。
- 2.除去陰道分泌物，增進病人清潔及舒適感受。
- 3.促進會陰、肛門處傷口之癒合。
- 4.以無菌技術留取導尿管之尿液檢體，以達檢體準確性。

（二）用物準備

1.存留導尿管護理

- (1)會陰沖洗壺。
- (2)溫水 300-500 cc (41-43°C)。
- (3)紗布或沖洗棉棒、小毛巾。
- (4)清潔手套。
- (5)洗手乳、沐浴乳或肥皂。
- (6)看護墊或便盆。
- (7)Mefix 一段。

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/11

2.存留導尿管拔除

(1)10 cc 空針。

(2)清潔手套。

3.尿液採檢

(1)橡皮筋 1 條或 Kelly 1 支（橡膠尿管）。

(2)消毒溶液：75%Alcohol、2%Tincture-Iodine 或 2% Chlorhexidine。

(3)6 吋棉棒 1 包。

(4)10 cc 空針、22-23#針頭。

(5)清潔手套。

(6)尿液檢體盒。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 系統／護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、頻率／核對狀態，核簽“正確”。	
2. 以二種以上之方式辨識病人，向病人或家屬解釋（說明目的及步驟），並評估病人外陰部狀況。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3. 備齊用物攜至病人單位，再次確認病人。	
4. 接觸病人前洗手。	
5. 準備環境及病人： (1)拉圍簾、關病房門，掛（治療中請勿打擾）牌子。	
(2)將床尾之被單反折至下腹部適當覆蓋後協助病人脫除褲子。	
(3)協助女病人採屈膝仰臥式並將兩腳分開。	男病人採平躺仰臥姿式即可。
6. 存留導尿管之護理：	

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/11

步驟	說明
(1)觀察尿液之量、顏色、有無沉澱物及氣味。	
(2)視病人外陰部情況，每日至少執行一次或依醫囑執行存留導尿管護理及會陰沖洗。	
(3)協助病人將褲子褪下，置看護墊或便盆於病人臀下，並露出導尿管。	
(4)執行清潔/無菌技術前洗手。	
(5)戴上手套，一手撥開病人陰唇後固定，手持沖洗壺將溫水潤濕尿道口後，用一手持小毛巾、紗布或沖洗棉棒沾洗手乳或沐浴乳清潔尿管依尿道口到尿管下方的方向，並涵蓋 5 公分長。	男病人由尿道口周圍環形清洗陰莖頭。 
(6)繼續以沾洗手乳（或肥皂）之紗布或棉棒，同上述步驟再清潔會陰處。	
(7)用溫水沖洗乾淨。 	若男性病人則將包皮推回以免造成嵌入性包莖。
(8)脫除手套。	
(9)暴露體液風險後洗手。	
(10) 每日重新更換固定導尿管之位置（女性固定於大腿內側；男性固定於下腹部或大腿前側）。	每班觀察導尿管及尿袋情形，包括引流系統有無密閉、扭結及受壓情形，蓄尿袋應每隔 8 小時排空一次或不可超過 8 分滿，以免發生尿液逆流，蓄尿袋位置保持低於膀胱、開口隨時關閉。
(11) 覆蓋病人之暴露部位。	
(12) 移去用物，整理病人單位。	

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/11

步驟	說明
(13) 清潔用物後歸位。	
(14) 接觸病人後洗手。	
(15) 完成護理系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽「已執行」。	
(16) 記錄：時間、陰道分泌量與性質、異常狀況。	報告可能異常的狀況，如：阻塞、滲尿、出現沉澱物等。
7. 存留導尿管之拔除：	
(1) 依醫囑行膀胱訓練(Bladder training)，增強尿液感。	
(2) 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、使用頻率，於核對狀態核簽「正確」。	
(3) 以二種以上之方式辨識病人，向病人或家屬解釋（說明目的及步驟）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(4) 備齊用物攜至病人單位，再次確認病人。	
(5) 拉布簾、關病房門。	
(6) 接觸病人前洗手，戴手套。	
(7) 倒除蓄尿袋內之尿液。	
(8) 鬆開固定導尿管之膠布。	
(9) 取 10c.c.空針銜接於存留導尿管之氣囊管腔後，抽出先前打入氣囊內之液體。	
(10) 教導病人深呼吸放鬆，輕拉出導尿管，脫除手套，脫手套過程將導尿管包覆在手套中；並告知拔管後 6~8 小時內須自行解尿。	需隨時評估病人是否已自解尿液。
(11) 暴露體液風險後洗手。	
(12) 協助病人穿好衣褲，採舒適臥位。	
(13) 移去圍簾，並整理床鋪及病人單位。	
(14) 時機 4 接觸病人後洗手。	
(15) 完成護理系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽「已執行」。	
(16) 記錄：拔管時間、尿道口情形、蓄尿袋內之尿量及病人反應等。	
8. 一般導尿管留取尿液檢體技術：	

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/11

步驟	說明
(1) 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、使用頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
(2) 以二種以上之方式辨識病人，向病人或家屬解釋（說明目的及步驟）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(3) 備齊用物攜至病人單位，再次確認病人。	
(4) 拉圍簾、關病房門。	
(5) 接觸病人前洗手。	
(6) 拿取橡皮筋將尿管反摺後綁住，約等 30 分鐘或病人主訴有尿液感，再將導尿管予抽取尿液檢體。	 此時鼓勵病人多喝水，使膀胱的尿液增加，以便抽取尿液足夠的檢體量。
(7) 準備用物：(如右圖) 6 吋棉棒 1 包、10cc 空針一支、23#針頭清潔手套、75%酒精溶液、2%碘酒消毒液或 2% Chlorhexidine。	 ALC Tr.
(8) 執行清潔/無菌技術前洗手。	
(9) 戴手套，於蓄尿袋銜接處以三消方式無菌抽取尿液，三消次序為： 75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol，或是使用 2%Chlorhexidine 消毒一次，等待消毒液揮發後再進行穿刺（如圖）。	 消毒區
(10) 取 10cc 空針，將針頭斜面朝上，抽取銜接蓄尿袋之尿管側（如圖），反抽針筒尿液至所需量。	抽取銜接蓄尿袋之尿管側是預防氣囊側被針頭戳破，導致固定尿管之氣體外漏因而尿管滑脫之危險。 （圖）尿管橫切面：

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/11

步驟	說明
抽取尿液時，勿將手放置於消毒尿管處下方，以避免針扎及染污消毒區。  	
(11)抽取尿液後注射至檢體盒並鬆綁橡皮筋。	
(12)暴露體液風險後洗手。	
(13)整理環境及用物： A. 協助病人穿好衣褲，採舒適臥位並整理環境。 B. 移去圍簾。	
(14)接觸病人後洗手。	
(15)完成護理系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽「已執行」。	
(16)記錄：時間、尿液顏色、性質等。	
9. 矽質導尿管留取尿液檢體技術：	
(1) 重新放置導尿管並留置尿液檢體，不可打開導尿管及尿袋導管的交接處，採絕對封閉。	請參考存留導尿法(A31000-Q05-W-A26)

備註：依 1981 年出版的美國疾病管制中心(CDC)對『導管相關之泌尿道感染預防指引』中建議，使用優碘或肥皂清水兩種清潔方法在防止微生物之進入泌尿道在統計上沒有差別，而以優碘清潔較易造成細菌的生長，有研究不建議使用優碘雖然目前這兩種方法仍爭議中，但在 Burke 等人(1981)的研究指出使用肥皂及清水做為導管護理較優碘好。

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/11

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/11

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林家綾等合著(2020)·排尿處置-存留導尿·最新內外科臨床護理教戰手冊-基本護理應用篇(1-10 頁)·台北：永大書局有限公司。
- (二) 林家綾等合著(2020)·排尿處置-拔除導尿管·最新內外科臨床護理教戰手冊(1-13 頁)·台北：永大書局有限公司。
- (三) 蘇麗智等合著(2022)·存留導尿法與其護理·實用基本護理學-技術篇（九版，413-420 頁）·台北：華杏。
- (四) 王月琴等合著(2023)·存留導尿法·基本護理學-技術篇(下冊)(九版，15-61-15-67)，台北：永大書局有限公司。

七、附件

(略)

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過
99.01.04	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
99.11.03	2.1	修改說明內容與參考資料	99 年 11 月 03 日 護理部技術標準 委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.03.18	3.1	更新參考資料版本	103 年 03 月 18 日 通過護理部技術 標準委員會。
104.03.17	3.2	第三項第(二)目用物準備新增：看護墊或便盆。 更新參考資料版本	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.3	1. 主題名稱原：存留導尿管之護理與拔除法；改為 ~導尿管之護理與拔除法及尿液採檢技術。 2. 目的內容增加留置導尿管之抽取尿液檢體技術。 3. 新增第三項第(一)目之 4: 以無菌技術留取導尿管 之尿液檢體，以達檢體準確性。 4. 第三項第(二)目用物準備增修部份內容。 5. 增修第三項第(三)目之 2 病人辨識之說明。 6. 新增第三項第(三)目之 8 一般導尿管留取尿液檢 體技術、及 9 矽質導尿管留取尿液檢體技術步驟 及圖示說明。 7. 第六項參考資料更新。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.05.09	3.4	第三項第二目之 3(5)新增 22-23#針頭。	107 年 05 月 09 日 護理長會議通過
108.03.18	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/11

修正日期	版本	修正說明	備註
		2. 第三項第三目之 8(8)新增或以 2% Chlorhexidine 消毒一次。 3. 第三項第三目之 8(9)圖片更新。 4. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	通過；108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.03.15	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.08	3.6	依『感委會_212070-ABA-P-003_導尿管放置之感染管制政策』修訂說明內容 1. 第三項第三目之 5 新增步驟及要點說明 2. 第三項第三目之 9.修訂說明內容	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過；111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
111.03.21	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	3.7	1. 修改第三項第二目 3.尿液採檢用物準備。 2. 修改第三項第三目之 8.(8)以統一技術標準消毒方式。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過；112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.03.18	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.03.17	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.8	1.主題名稱「法」改為「技術」 2.第三項第三目內容依 bundle 加入洗手五時機內容修訂 3.更新參考資料	114 年 12 月 15 日、115 年 3 月 16 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 11 日護理長會

主題名稱	存留導尿管之護理與拔除技術及尿液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A27	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
			議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。